

EXAMEN CLINIQUE

Pour chaque patient, débiter le status par l'inspection générale (signes vitaux, perfusion des extrémités, conjonctive, cyanose, turgescence jugulaire, oedèmes)

Status cardiaque :

1. Inspection

- Inspection générale du patient couché à 30°

Signes d'insuffisance cardiaque gauche : dyspnée, râles crépitants, B3, tachycardie, souffle systolique (insuffisance mitrale), déviation du choc de pointe

Signes d'insuffisance cardiaque droite : œdèmes des membres inférieurs, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, tachycardie, souffle systolique (insuffisance tricuspide)

- Fréquence cardiaque
- Inspections du thorax (symétrie, pacemaker)

2. Palpation

- Palpation du thorax à la recherche de douleurs et du choc de pointe
- Reflux ^hhépato-jugulaire
- Auscultation des carotides et palpation des pouls carotidiens

3. Auscultation

- Auscultation des 4 foyers (A-P-T-M)

B1 correspond à la fermeture des valves AV (mitrale et tricuspide) et B2 à la fermeture des valves semi-lunaires (aortique et pulmonaire)

- Dédoublement B2 à l'inspiration profonde au foyer d'Erb (3^{ème} EIC)

Souffle systolique avec irradiation carotidienne (sténose aortique) ou avec irradiation axillaire (insuffisance mitrale)

Souffle diastolique sans irradiation (sténose mitrale) ou avec irradiation à l'apex (insuffisance aortique)

Péricardite : à l'ECG sus-décalage diffus du segment ST

Traitement initial de l'infarctus : MONA (Morphine, Oxygène, Nitrés, Aspirine)

Status vasculaire :

1. Inspection

- Inspection générale du patient
- Fréquence cardiaque

2. Palpation

- Auscultation des carotides et palpation des pouls carotidiens
- Pouls brachiaux
- Pouls radiaux
- Pouls cubitaux
- Auscultation des fémorales et palpation des pouls fémoraux
- Pouls poplités
- Pouls tibiaux postérieurs
- Pouls pédiens

Prendre les pouls si suspicion d'atteinte vasculaire (fracture, perte de sensibilité)

Status pulmonaire :

1. Inspection

- Inspection générale du patient
- Inspection du thorax (symétrie, cicatrice)

Asterixis (main en extension) pour hypercapnie ou encéphalopathie hépatique

Respiration de Cheyne-Stokes : hyperventilation et apnée (insuffisance cardiaque, apnée centrale du sommeil, atteinte des centres respiratoires)

- Fréquence respiratoire
- Mouvements respiratoires (signes de détresse respiratoire)

2. Palpation

- Palpation des ganglions sous-mandibulaires, sterno-cléido-mastoïdien, sus-claviculaires, cervicaux et axillaires
- Palpation du thorax à la recherche de douleurs
- Ampliation thoracique
- Fremitus
- Percussion des plages pulmonaires antérieures, latérales, postérieures et délimitation (matité du foie, tympanisme gastrique, matité des reins)

La matité peut être signe d'un épanchement ou d'une pneumonie

Le tympanisme peut être signe d'un pneumothorax

3. Auscultation

- Auscultation de la trachée
- Auscultation des plages pulmonaires antérieures, latérales et postérieures

Traitement initial de l'OAP : MONA (Morphine, Oxygène, Nitrés, CPAP)

Status abdominal :

1. Inspection

- Inspection générale du patient (visage douloureux)
- Inspection de l'abdomen (cicatrice)

2. Auscultation

- Auscultation des 4 quadrants en commençant par la zone non-douloureuse
- Auscultation de l'aorte (souffle)

3. Palpation

- Percussion des 4 quadrants
- Délimitation du foie
- Palpation superficielle, profonde et détente des 4 quadrants
- Palpation de l'aorte
- Palpation sus-pubienne
- Palpation du foie
- Palpation de la rate
- Signe de Murphy (à l'inspiration)
- Point de McBurney, signe du Psoas et signe du Psoas inversé
- Orifices herniaires au lever de tête du patient
- Percussion des reins chez le patient assis
- Toucher rectal

Traitement initial des néphrolithiases : hydratation iv., AINS, tamsolusine (α -blocker)

Status neurologique :

1. Nerfs crâniens

- Nerf olfactif (I) : tester une narine après l'autre
- Nerf optique (II) : tester les champs visuels, l'acuité visuelle de près et de loin et les couleurs, tester les réflexes pupillaires directs, consensuels et à la menace, fond d'œil

Si pas de myosis à la lumière le nerf optique est lésé (reçoit la lumière)

Si le myosis est asymétrique à la lumière le nerf oculomoteur de l'œil non contracté est lésé

- Nerfs oculomoteur (III), trochléaire (IV) et abducens (VI) : motricité de l'œil

Le nerf trochléaire innerve le muscle oblique supérieur (mouvement d'adduction, vers le bas)

Le nerf abducens innerve le muscle droit latéral (mouvement d'abduction)

- Nerf trijumeau (V) : tester la sensibilité, le réflexe masséter et le réflexe cornéen

Réflexe cornéen : le toucher sur la cornée excite l'efférence du nerf trijumeau et la fermeture des paupières se fait par l'afférence du nerf facial)

- Nerf facial (VII) : tester la motricité du visage
- Nerf vestibulo-cochléaire (VIII) : tester l'audition en masquant l'oreille controlatérale, tester le Rinné et Weber, test de Halmagyi

Test de Weber : latéralisation du côté sain (surdité de transmission) ou du côté atteint (surdité de perception)

Test de Rinné : positif si CA > CO (surdité de transmission)

Test de Halmagyi : positif si le patient doit effectuer une saccade de correction

- Nerf glossopharyngien (IX) et vague (X) : déviation de la luette, tester le réflexe vomitif, tester la déglutition
- Nerf accessoire (XI) : motricité des trapèzes et des sterno-cléido-mastoïdiens
- Nerf hypoglosse (XII) : motricité de la langue

Syndrome de Horner : myosis, ptose, anhidrose, enophtalmie (origine centrale dans le syndrome de Wallenberg, pré-ganglionnaire dans la tumeur de Pancoast ou post-ganglionnaire dans l'infection HSV et les céphalées cluster)

Syndrome de Wallenberg : débute par un grand vertige rotatoire, nystagmus, syndrome cérébelleux, signe de Horner, atteinte du nerf trijumeau, paralysie du voile du palais et anesthésie thermoalgique du côté opposé (atteinte de la PICA)

2. Inspection

- Marche : aller-retour, pointes (S1), talons (L5), test de Trendelenburg

Fauchage : atteinte des voies motrices centrales, spasticité sévère

Steppage : atteinte périphérique des releveurs du pied

Syndrome parkinsonien : marche à petits pas

Syndrome cérébelleux : élargissement du polygone de sustentation

3. Palpation

- Palpation des loges supérieures et/ou inférieures
- Tonus musculaire (résistance passive), roue dentée

Hypertonie : syndrome pyramidal et syndrome parkinsonien (roue dentée)

Hypotonie : déficits moteurs périphériques

4. Force musculaire

- Membre supérieur
- Membre inférieur
- Épreuve des bras tendus et des jambes fléchies (Mingazzi)
- Signe de Gowers (patient s'accroupit et se relève)
- Épreuve du tabouret
- Motricité fine

5 = normal, 3 = maintien contre gravité

Épreuve des bras tendus : flexion et supination si atteinte lésion du faisceau pyramidal contro-latéral

Signe de Gowers : positif dans maladie de Duchenne (parésie des muscles proximaux)

5. Réflexes

- Membre supérieur
- Membre inférieur
- Abdominal (*atteinte pyramidale*)
- Babinski

2+ = normal, 4+ = pyramidal, 1+ = périphérique

6. Sensibilité

- Sensibilité grossière
- Toucher-piquer
- Proprioception (sens de position)
- Pallesthésie (sens vibratoire)
- Démarche du funambule
- Épreuve de Romberg

Romberg : positif si trouble de l'équilibre à la fermeture des yeux (atteinte du sens de position), négatif si la fermeture des yeux n'aggrave pas le déséquilibre (atteinte cérébelleuse)

7. Coordination

- Marionnettes
- Épreuve doigt-nez
- Épreuve genou-talon
- Épreuve de rebond

Épreuve de Rebond : positive dans le syndrome de Parkinson

8. Signes méningés

- Signe de Brudzinski (flexion de la tête)
- Signe de Kernig (flexion de la hanche, puis étendre le genou)
- Réflexes vifs

9. Radiculopathie ou hernie discale

- Signe de Lasègue (élévation du membre inférieur étendu)
- Amyotrophie du mollet
- Faiblesse de la dorsiflexion du pied
- Perte de sensibilité, paresthésies
- Abolition des réflexes

Syndrome du canal lombaire étroit : congénital ou acquis avec des hernies discales étagées ou arthrose visualisée

10. Syndrome de la queue de cheval (syndrome neurogène périphérique)

- Perte de sensibilité, anesthésie en selle, paresthésies
- Déficit moteur (marche sur la pointe des pieds et les talons)
- Abolition des réflexes
- Troubles sphinctériens

Le syndrome de la queue de cheval peut venir d'une hernie discale latérale ou médiane, d'un épendymome ou d'un syndrome du canal lombaire étroit

Status ORL

1. Inspection

- Inspection face et cuir chevelu
- Inspection des yeux (conjonctives)

2. Palpation

- Palpation du crâne
- Palpation des sinus
- Palpation de la mastoïde
- Palpation des ganglions sous-mandibulaires, sterno-cléido-mastoïdien, sus-claviculaires, cervicaux et axillaires
- Palpation de la thyroïde

3. Yeux

- Oculomotricité
- Réflexes pupillaires directs, consensuels et à la menace
- Tester les 4 quadrants et la périphérie
- Acuité visuelle de loin et de près
- Tester les couleurs (table d'Ishihara)
- Fond d'oeil

4. Oreilles

- Tester l'audition en masquant l'oreille opposée
- Test de Rinne
- Test de Weber
- Otoscopie

5. Bouche

- Fond de gorge

6. Nez

- Inspection au spéculum

GALS

1. Questions

- Douleurs ou raideurs dans les articulations, muscles ou dos ?
- Difficultés pour s'habiller ou se déshabiller ?
- Difficultés pour monter ou descendre les escaliers ?

2. Inspection

- Aller-retour et marche sur pointes et talons
- Inspection antérieure, latérale et postérieure

3. Rachis

- Mobilité de l'articulation temporo-mandibulaire et de la tête
- Inclinaison latérale de la colonne et rotation
- Extension de la colonne et flexion (Schobert et distance doigts-sol)

4. Membres supérieurs (debout)

- Lever les mains derrière la tête
- Palm-up
- Extension des coudes (pronation et supination)
- Force de préhension des mains, pianotage et squeeze test

5. Membres supérieurs (décubitus dorsal)

- Mobilité de la hanche
- Mobilité du genou
- Tester les ligaments collatéraux du genou
- Signe du glaçon
- Squeeze test du pied

Status du rachis

1. Inspection

- Aller-retour et marche sur les pointes et talons
- Inspection postérieure, latérale et antérieure

2. Palpation

- Percussion des vertèbres
- Palpation des processus épineux
- Palpation des muscles paravertébraux
- Palpation de l'articulation sacro-iliaque (au niveau des épines iliaques) et points de Valleix (*sciatalgie*)

3. Mobilisation active

- Mobilité de l'articulation temporo-mandibulaire et de la tête
- Inclinaison latérale de la colonne et rotation
- Extension de la colonne et flexion (Schobert et distance doigts-sol)

4. Investigations neurologiques selon le niveau douloureux

- Sensibilité grossière
- Réflexes
- Motricité grossière
- Signe de Spurling (rotation et inclinaison ipsilatérale de la tête)
- Signes de Lasègue (lever la jambe tendue) et Bragard (lever la jambe tendue et faire une dorsiflexion du pied)
- Signe de Lasègue inversé
- Sautiller sur une jambe (coxarthrose)
- Toucher rectal (syndrome de la queue de cheval)

Signe de Spurling : hernie discale cervicale

Signes de Lasègue et Bragard : sciatalgie

Signe de Lasègue inversé : cruralgie (nerf fémoral)

Status de l'épaule

1. Inspection

- Inspection antérieure, latérale et postérieure

2. Palpation

- Température, trophicité et douleurs musculaires
- Palpation des articulations sterno-claviculaire, acromio-claviculaire et gléno-humérale
- Palpation de la gouttière bicipitale

3. Mobilité active et passive

- Flexion et extension
- Abduction et adduction
- Rotation externe et interne (distance pouce-C7)

4. Tests fonctionnels

- Test de Jobe (supra-épineux)
- Rotation externe (sous-épineux)
- Signe du Portillon en déplaçant passivement le bras fléchi (sous-épineux)
- Rotation externe avec bras en abduction (petit rond)
- Signe du Clairon (petit rond)
- Belly-press ou Lift-off de Gerber (sous-scapulaire)
- Palm-up (tendon du long chef du biceps)
- Test de Neer (conflit sous-acromial)
- Tiroirs antérieur et postérieur
- Laxité inférieure
- Appréhension antérieure

Signe du Clairon : positif si impossibilité à amener sa main à la bouche sans lever le coude

Test de Neer : bras en pronation, immobiliser l'épaule et fléchir le bras du patient

Status du coude

1. Inspection

- Inspection antérieure, latérale et postérieure

2. Palpation

- Température, trophicité et douleurs musculaires
- Palpation des épicondyles latéraux et médiaux
- Palpation de l'olécrâne (insertion du triceps)
- Palpation du tendon du biceps et Hook test

3. Mobilité active et passive

- Flexion et extension
- Supination et pronation

4. Tests fonctionnels

- Tennis elbow (palpation de la trochlée latérale et extension passive)
- Golfer elbow (palpation de la trochlée médiale et flexion passive)
- Signe de Froment (nerf ulnaire)
- Signe de Tinel (percussion du nerf ulnaire)
- Sensibilité de la main
- Ligaments collatéraux

Status de la main

1. Inspection

- Inspection antérieure, latérale et postérieure

2. Palpation

- Température, trophicité et douleurs musculaires
- Palpation de l'ulna et du radius
- Palpation des os du carpe
- Palpation des métacarpes et phalanges
- Temps de recoloration capillaire
- Pouls radial et cubital

3. Mobilité et motricité

- Mobilité du poignet
- Flexion superficielle et profonde des doigts
- Extension commune des doigts et propre de D2 et D5
- Abduction et opposition de D5
- Extension du pouce
- Flexion superficielle et profonde du pouce
- Abduction, adduction et opposition du pouce

4. Sensibilité

- Paume latérale D1-D4 (nerf médian)
- Face dorsale médiale D1-D2 (nerf radial)
- Paume médiale D4-D5 et dace dorsale médiale D3-D5 (nerf ulnaire)

5. Tests fonctionnels

- Effet ténodèse
- Pouce du skieur (test du ligament collatéral interne)
- Signe de Froment (nerf ulnaire)
- Fickelstein (1^{ère} coulisse des extenseurs)
- Test d'Allen (perfusion de la main)
- Test de Tinel (percussion du nerf médian) et Phalen (mains en flexion)

Fickelstein : pouce dans poing et inclinaison ulnaire

Status de la hanche

1. Inspection

- Inspection antérieure, latérale et postérieure
- Aller-retour et marche sur les pointes et talons
- Test de Trendelenburg
- Taille des membres inférieurs chez le patient couché

2. Palpation

- Température, trophicité et douleurs musculaires
- Palpation des épines iliaques antéro-supérieures et des trochanters
- Palpation du fessier et du nerf sciatique
- Palpation des pouls fémoraux, poplité, tibial postérieur et pédieux

3. Mobilité active et passive

- Flexion et extension
- Abduction et adduction
- Rotation externe et interne

4. Tests fonctionnels

- Test de Faber (distance genou-table)
- Signe de Lasègue
- Signe de Lasègue inversé
- Test de Thomas (courbure du dos s'aplatit quand on ramène les genoux)
- Sensibilité grossière
- Motricité grossière

Status du genou

1. Inspection

- Inspection antérieure, latérale et postérieure
- Marche

2. Palpation

- Température, trophicité et douleurs musculaires
- Palpation de l'interligne articulaire
- Palpation de la patella
- Palpation du creux poplité
- Signe du glaçon
- Pouls poplité

3. Mobilité active et passive

- Flexion et extension
- Rotation externe et interne en flexion
- Laxité médiale et latérale en extension et à 30°

4. Tests fonctionnels

- Tiroirs antérieurs et postérieurs
- Test de Lachman (ligament croisé antérieur)
- Test de McMurray (palper interligne et rotation externe et interne)
- Test d'Appley (décubitus ventral, rotation externe et interne en flexion et étendre lentement la jambe)

Test de McMurray et test d'Appley testent les ménisques

Status du pied

1. Inspection

- Inspection antérieure, latérale et postérieure
- Aller-retour et marche sur les pointes et talons

2. Palpation

- Température, trophicité et douleurs musculaires
- Palpation des malléoles externes et internes
- Palpation de la fibula, du tibia et des tarse
- Squeeze test
- Palpation des pouls tibial postérieur et pédieux

3. Mobilité active et passive

- Flexion et extension de la cheville et des orteils
- Inversion et éversion

4. Tests fonctionnels

- Motricité grossière
- Toucher-piquer, pallesthésie et proprioception
- Réflexes
- Tiroirs antérieurs et postérieurs
- Talar tilt test inversion (varus forcé)
- Talar tilt test eversion (valgus forcé)
- Palpation du fascia (fasciite nécrosante)
- Test de Thompson (compression des gastrocnémiens en décubitus ventral)

Talar tilt test inversion : teste le faisceau moyen du ligaments calcanéo-fibulaire

Talar tilt test eversion : teste le ligament interne

Test de Thompson : test le tendon d'Achille